

Nieświadomy *konflikt*

Wewnątrz psychiki ścierają się sprzeczne dążenia — bliskość vs lęk przed zależnością, złość vs miłość. Gdy jedna strona jest wypierana, wraca jako objaw, napięcie albo powtarzalny wzorzec.

CZAS: 20 min Sesja 2-4; gdy pacjent pyta „jak coś, czego nie wiem, może mnie prowadzić?”

ŹRÓDŁO: Freud; Solms (2018); Fonagy & Target (1997)

JAK UŻYWAĆ

Wyjaśniasz pacjentowi rdzeniowe założenie STPP: w psychice istnieją **sprzeczne dążenia** (np. pragnienie bliskości vs lęk przed zależnością, złość na bliską osobę vs miłość do niej). Konflikt jest nieświadomy, gdy jego jedna strona — zwykle „niedozwolona” afektywnie — jest wypierana. Używasz metafory góry lodowej, normalizujesz sprzeczne uczucia i pokazujesz mechanizm: wyparte uczucie wraca inaczej — napięciem, objawem, relacjami.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Współczesne rozumienie nie wymaga klasycznej metapsychologii: nieświadomość to procesy **niedostępne introspekcji, ale wpływające na zachowanie, emocje i percepcję**. Wspierają to dowody neuronauki (ciało migdałowe przetwarza zagrożenie poza świadomością; afekty pierwotne jako struktury podkorowe — Panksepp) i badania nad mentalizacją (Fonagy). STPP nie „wyjaśnia” nieświadomego intelektualnie — pozwala mu wybrzmieć przez afekt i wzorzec relacyjny, bo sama wiedza nie wystarcza do zmiany.

01



Pięć wskaźników konfliktu

Nie przyjmuj świadomej narracji pacjenta jako pełnej — wsluchuj się w to, co poza nią. Te pięć sygnałów wskazuje na nieświadomy konflikt:

- ① luki i niespójności w narracji
- ② silne emocje w „neutralnych” tematach
- ③ powtarzające się wzorce relacyjne
- ④ somatyzacje bez przyczyny medycznej
- ⑤ sny i przejęzyczenia

02



Pokaż mechanizm

„Jeśli w dzieciństwie złość była karana — uczysz się jej nie odczuwać. Ale ona tam jest. Wychodzi inaczej: napięciem, depresją, w relacjach.” Zapisz, jaki konflikt wydaje się centralny u tego pacjenta.

ROBOCZY NIEŚWIADOMY KONFLIKT

03 Dlaczego wiedza nie wystarcza

„Gdyby wystarczyło wiedzieć — terapia trwałaby godzinę. Potrzebne jest doświadczenie: w bezpiecznym kontekście poczuć to, co było blokowane.” Odróżnij też od stereotypu: nie chodzi o „kompleksy z dzieciństwa”, lecz o afekty i relacje, które nie zostały zintegrowane.

JAK WYJAŚNIĘ TO TEMU PACJENTOWI

04 Zaproś obserwację między sesjami

„Proszę notować momenty, gdy coś Panią/Pana zaskakuje w reakcji — śmiech, kiedy nie do śmiechu; smutek, gdy wydaje się 'bez powodu'. To ślady nieświadomego.” Zapisz, co pacjent przyniósł.

ŚLADY NIEŚWIADOMEGO PRZYNIESIONE PRZEZ PACJENTA

Klucz: pacjent uformowany w kulturze racjonalnej często traktuje „nieświadome” z rezerwą. Nie walczyć argumentami — dać doświadczenie. Po kilku sesjach zwykle pojawia się zdanie: „nie wiedziałam, że to we mnie siedzi”. To rozpoznanie pojęcia przez doświadczenie, nie przez wyjaśnienie.